M2 - Uro/Nefro

1. A drenagem linfática da próstata, principalmente, para os linfonodos obturadores e ilíacos internos (INCOMPLETO) início do enunciado cortado.

A) Inguinais profundos.
B) Pré-sacrais.
C) Inguinais superficiais.
D) Retroperitoneais.
E) Do hilo renal.

2. Na realização da uretrotomia interna para uma estenose de uretra peniana, a complicação mais frequente é:

A) Recorrência da estenose.
B) Hemorragia.
C) Extravasamento de líquidos para os tecidos periesponjosos.
D) Disfunção erétil.
E) Formação de fístulas espongiocavernosas.

3. A principal diferença da ressecção transuretral da próstata bipolar para a monopolar é o menor risco de:

A) Estenose de colo, com necessidade de retratamento.
B) Disfunção erétil.
C) Sangramento peroperatório.
D) Estenose de uretra.
E) Incontinência urinária.

4. A respeito dos pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica com uso de CO_2 para insuflação, com mais de (ILEGÍVEL) hora de duração, assinale a opção que indica em qual deles deve ser feito o controle gasométrico por algum tempo depois do fim da anestesia, devido ao risco de hipercapnia.

A) Naqueles com DPOC.
B) Naqueles com asma leve.
C) Naqueles com insuficiência cardíaca.
D) Naqueles com cirurgias com duração de mais de 3 horas.
E) Em todos os pacientes submetidos a cirurgia renal.

5. O indivíduo transplantado renal tem maior risco de desenvolver câncer, devido à imunossupressão crônica (INCOMPLETO). No paciente, o órgão em que mais raramente ocorrerá câncer é o(a):

A) Fígado.
B) Rim.
C) Bexiga.
D) Próstata.
E) Pênis.

6. A presença de glândulas pequenas e atípicas na biópsia prostática, implica em:

A) Nova biópsia, imediatamente.
B) Utilizar a imuno-histoquímica para marcadores de células basais.
C) Fazer ressonância magnética multiparamétrica.
D) Nova biópsia em 2 meses.
E) Prostatectomia radical.

7. (INCOMPLETO) início do enunciado cortado. (ILEGÍVEL) usados no tratamento da bexiga hiperativa podem provocar os sintomas listados a seguir. Assinale-o.

A) Boca seca.
B) Constipação intestinal.
C) Piora do glaucoma.
D) Hipertensão arterial.
E) Alterações cognitivas.

8. Durante uma prostatectomia radical de resgate, após radioterapia pélvica, é observada uma lesão retal de 2 cm. Assinale a opção que indica a conduta mais segura.

A) Reparo imediato em dois planos.
B) Colostomia apenas.
C) Reparo imediato em dois planos e sonda retal.
D) Interrupção da cirurgia, reparo em dois planos e bloqueio hormonal.
E) Reparo imediato em dois planos e colostomia.

9. No paciente idoso com hematúria e tabagista, define:

A) O sangramento como glomerular.
B) O sangramento como caliceal.
C) Indica a necessidade de cistoscopia.
D) Indica a realização de citologia urinária.
E) Não indica a origem do sangramento.

10. Sobre o paciente com micro-hematúria, assinale a opção que indica o fator que não é importante em termos de risco de malignidade associada.

A) Tabagismo.
B) Irradiação pélvica prévia.
C) Exposição a corantes.
D) História familiar de hematúria.
E) Idade acima de 35 anos.

11. A neoplasia prostática afeta mais comumente qual zona prostática respectivamente:

A) Zona periférica.
B) Zona de transicional.
C) Zona central.
D) Zona peri-uretral.
E) Estroma fibromuscular.

12. A úlcera de Hunner refere-se à:

A) Cistite eosinofílica.

B) Cistite glandular.
C) Cistite interticial.
D) Cistite cística.
E) Cistite tuberculosa.

13. Qual o exame de primeira linha para o diagnóstico de câncer de próstata:

A) O exame retal digital (ERD).
B) A análise do antígeno específico da próstata (PSA).
C) Ressonância magnética de próstata.
D) Ultra-sonografia transretal.
E) A combinação de ERD e PSA.

14. Para o câncer de próstata de muito baixo risco qual tratamento é recomendado:

A) Prostatectomia radical.
B) Radioterapia.
C) Vigilância ativa.
D) Quimioterapia.
E) Hormonioterapia.

15. Qual a mais frequente complicação de cirurgia de próstata:

A) Disfunção erétil.
B) Incontinência urinária.
C) Incontinência fecal.
D) Fístula urinária.
E) Hematúria.

16. Paciente de sexo masculino, 26 anos, com vida sexual ativa (ILEGÍVEL). (INCOMPLETO) parte do caso clínico não pode ser lida com segurança. Para confirmar a hipótese diagnóstica, dentre as alternativas, qual exame seria mais indicado e confirmaria o diagnóstico?

A) Bacterioscopia pelo Gram da secreção do bulbo, com ênfase na pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extracelulares.
B) (ILEGÍVEL)
C) (ILEGÍVEL)
D) (ILEGÍVEL)

17. Paciente de 36 anos de idade, feminina, apresentando queda de cabelo, dores articulares e dor no corpo e nas últimas semanas vem apresentando “inchaço” e edema de membros inferiores. O exame Fator Anti Nuclear (FAN) apresentou-se positivo, com título de 1280 e padrão nuclear pontilhado fino. O seu EAS apresentou o seguinte resultado:

Exame físico/químico: COR - amarelo escuro (VR: amarelo citrino); CHEIRO - sui generis; ASPECTO - ligeiramente turvo; DEPÓSITO - moderado; DENSIDADE - 1025; pH - 6,0; NITRITO - negativo; PROTEÍNAS - 2800 mg/dL; GLICOSE - 0 mg/dL; CORPOS CETÔNICOS - ausente; UROBILINOGÊNIO - 1 mg/dL; BILIRRUBINA - ausente; HEMÁCIA - presente (+/4+); HEMOGLOBINAS - presente.

Exame microscópico: LEUCÓCITOS - 15.000/mL; MUCO - presente (++/4+); HEMÁCIAS TOTAIS - 20.000/mL; HEMÁCIAS ISOMÓRFICAS - 15.000/mL; HEMÁCIAS DISMÓRFICAS - 5.000/mL; CÉLULAS UROTELIAIS - 15.000/mL; CÉLULAS TUBULARES - 8.000/mL; CRISTAIS - oxalato de cálcio (+/4+); CILINDROS HIALINOS - 4.000/mL; OUTROS CILINDROS - gordurosos: 2.000/mL. NO SORO: COLESTEROL - 340 mg/dL; ALBUMINA - 2,9 mg/dL.

Considerando a exposição acima, com estes dados, responda que enfermidade melhor explica esses achados clínicos/laboratoriais?

A) Síndrome nefrítica - Glomerulonefrite Aguda (GNDA).
B) Síndrome nefrótica - Nefropatia lúpica.
C) Síndrome nefrítica - Nefropatia lúpica.
D) Síndrome nefrótica - Glomerulonefrite Aguda (GNDA).

18. EM UM PACIENTE INTERNADO COM SUSPEITA DE SEPSE, QUAL EXAME DEVE SER SOLICITADO PARA DIAGNOSTICAR MAIS PRECOCEMENTE INJÚRIA RENAL AGUDA (IRA) (Escolha a melhor alternativa dentre as abaixo):

A) Ácido úrico sérico.
B) Ureia sérica.
C) NGAL.
D) Nitrogênio ureico sérico (BUN).

19. Qual paciente com doença renal crônica na classificação KDIGO tem maior chance de morrer?

A) G2A1.
B) G5A3.
C) G4A2.
D) G3A3.

20. Qual dessas fórmulas é a mais recomendada atualmente para cálculo da taxa de filtração glomerular em adultos?

A) Cockcroft-Gault.
B) CKD-EPI.
C) MDRD.
D) CKD-EPI 2021.
E) Schwartz.

21. Qual dessas fórmulas é a mais recomendada atualmente para cálculo da taxa de filtração glomerular em crianças?

A) Cockcroft-Gault.
B) CKD-EPI.
C) MDRD.
D) CKD-EPI 2021.
E) Schwartz.

22. Na nefropatia por lesões mínimas (nefrose lipoídica) as células mais afetadas são:

A) Endoteliócitos.
B) Mesangiócitos.
C) Podócitos.
[Alternativa D: INCOMPLETO — não aparece na fotografia.]
E) Histiócitos.

23. De acordo com a fisiopatologia que acomete as doenças glomerulares, escolha o diagnóstico que melhor relacione fisiopatologia e doença, respectivamente:

A) Depósito de imunocomplexo na luz do capilar glomerular - Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa.
B) Lesão da membrana basal glomerular associada a anticorpo anti-membrana basal - Doença por Lesão Mínima.
C) Lesão da membrana basal glomerular associada a anticorpo anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA) - Glomerulopatia membranosa.
D) Depósito de imunocomplexo na membrana basal glomerular com apagamento difuso dos podócitos - Glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE).

24. Paciente do sexo feminino, 25 anos, procura atendimento com queixa de edema peri-orbital, diminuição da diurese, urina escura, cefaleia, escotomas visuais, embaçamento visual, dispneia progressiva. Ao exame físico encontra-se hipertensa (PA 220/140 mmHg), edema periorbital importante e estertores pulmonares bilaterais. Traz exames de outro serviço que mostram FAN + 1:320, padrão pontilhado fino, complemento C3 e C4 consumidos, anti-DNA reagente, creatinina 1,8 mg/dL, EAS com hematúria, proteinúria, leucocitúria e cilindros hemáticos. Suas principais hipóteses diagnósticas sindrômica e etiológica são respectivamente:

A) Síndrome nefrótica - Glomerulonefrite membranosa idiopática.
B) Síndrome nefrótica - Glomeruloesclerose segmentar e focal.
C) Síndrome nefrítica - Nefrite lúpica (glomerulonefrite proliferativa).
D) Glomerulonefrite rapidamente progressiva - Síndrome do Bom Pastor.

25. Paciente do sexo masculino, 52 anos inicia quadro compatível com síndrome nefrótica, e encaminhado à (ILEGÍVEL) biópsia renal e realização de exames. O resultado da biópsia renal mostra membrana basal glomerular espessada na coloração por hematoxilina-eosina (HE) e presença de espículas (spikes) na coloração pela prata. Realiza também pesquisa de anti-PLA2R sérico que veio positiva, com títulos elevados. De acordo com estes dados, sua principal hipótese diagnóstica é:

A) Doença por lesão mínima.
B) Nefropatia membranosa primária.
C) Glomeruloesclerose segmentar e focal.
D) Glomerulonefrite membranosa secundária.

26. Paciente com diagnóstico recente de HIV, com carga viral elevada e CD4 baixo, procura serviços médicos devido a quadro compatível com síndrome nefrótica onde foi submetido a biópsia renal. Das formas de doença glomerular associada ao HIV, destaca-se a:

A) Doença por lesão mínima.
B) Glomerulonefrite membranoproliferativa.
C) Doença de Berger (nefropatia por IgA).
D) Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF colapsante).

27. Homem de 56 anos com creatinina alta há 4 meses (para determinar Doença Renal Crônica as alterações devem ser >= 3 meses), creatinina = 4,0 mg/dL (valor relativo normal = 0,4 a 1,2 mg/dL). Qual o diagnóstico provável?

A) Injúria Renal Aguda.
B) Doença Renal Crônica.

C) Rins normais.
D) Doença Renal Aguda.

28. Marque a alternativa certa quanto ao diabetes e o rim:

A) Na nefropatia diabética a microalbuminúria está acima de 300 mcg/mg de creatinina.
B) Na doença renal do diabetes se a taxa de filtração glomerular estiver acima de 100 mL/min/1,73 m²SC, seu diagnóstico não é confirmado.
C) Na glomerulopatia diabética ocorre a hialinose de arteríolas aferentes, poupando as arteríolas eferentes.
D) O último estágio da doença renal do diabetes é atingido pela minoria dos diabéticos.

29. Em um paciente adulto com múltiplos cistos renais, a maior chance de diagnóstico é:

A) Esclerose tuberosa.
B) Doença renal policística autossômica dominante.
C) Rim em esponja medular.
D) Doença renal policística autossômica recessiva.

30. No paciente grande queimado, qual destes distúrbios eletrolíticos que você espera encontrar?

A) Hiponatremia HIPOVOLÊMICA.
B) Hipernatremia HIPERVOLÊMICA.
C) Hiponatremia HIPERVOLÊMICA.
D) Hipernatremia HIPOVOLÊMICA.

31. Na necrose tubular aguda, a sobrevida do paciente é:

A) Maior na medida em que avança na classificação do KDIGO.
B) Maior na medida em que ocorre comprometimento de outros órgãos.
C) Menor na pré-renal que na renal.
D) Menor na anúria que na não oligúrica.

32. Paciente de 22 anos de idade, com síndrome urêmica, hipertenso, oligúrico. Fez exames que mostram ureia plasmática = 320 mg/dL e creatinina 22 mg/dL. Outros exames deverão com maior probabilidade mostrar:

A) Hipernatremia.
B) Hipercalemia.
C) Alcalose metabólica.
D) Hipomagnesemia.

33. Paciente hipertenso, com TFG = 22 mL/min/1,73 m²SC, a qual é reduzida há anos, apresenta anemia, hemoglobina = 8 g/dL. O que pode contribuir para essa anemia?

A) Aumento da ligação do ferro às metahemoglobinas.
B) Diminuição pelo fígado da liberação de hepcidina.
C) Uso de anti-inflamatórios não hormonais.
D) Intoxicação por vitamina B12.

34. Na síndrome cardiorrenal tipo 1 encontramos:

A) Alteração aguda da função renal levando à insuficiência cardíaca.
B) Alteração sistêmica afetando ao mesmo tempo rim e coração.

C) Alteração cardíaca aguda levando a disfunção renal.
D) Alteração renal crônica levando a comprometimento cardíaco.

35. Quanto à sobrevivência na doença renal crônica terminal:

A) A diálise peritoneal oferece maior sobrevida que a hemodiálise.
B) O paciente diabético apresenta sobrevida semelhante ao de glomerulonefrite crônica.
C) O transplante renal oferece maior quantidade de vida que a diálise.
D) No transplante renal intervivos a sobrevida é menor que no cadavérico.

36. Na doença mineral óssea que acomete o portador de doença renal crônica terminal, a osteomalácia é devida a:

A) Intoxicação pelo alumínio.
B) Hiperparatiroidismo terciário.
C) Iatrogenia por excesso de vitamina D e análogos.
D) Deficiência de cálcio.

37. A furosemida:

A) Inibe a bomba Na-K-ATPase basolateral.
B) Bloqueia o canal de K luminal.
C) Bloqueia o cotransportador Na-K-2Cl luminal.
D) Diminui a permeabilidade a íons dos espaços intercelulares.

38. Os estudos laboratoriais de uma mulher hipertensa (160/110 mmHg) mostram níveis séricos de potássio muito (ILEGÍVEL) (2,7 mEq/L) e alto nível de sódio e H2CO3. A associação de ..... será a mais adequada nessa paciente.

A) Espironolactona + Hidroclorotiazida.
B) Furosemida + Clorotiazida.
C) Hidroclorotiazida + Glicerina.
D) Manitol + Acetazolamida.

39. A nefropatia medicamentosa ocasionada pelo uso constante de analgésicos e anti-inflamatórios é um dos principais problemas enfrentados por pacientes portadores de doenças crônicas de origem inflamatória, os quais fazem tratamento à base destes medicamentos. Em relação à nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios, assinale a alternativa CORRETA.

A) Apenas os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) não seletivos para COX-2 são capazes de desencadear a nefropatia induzida por anti-inflamatórios.
B) A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por uma redução da produção dos eicosanoides prostaglandina E2 e prostaciclina no rim, os quais estão envolvidos na manutenção da homeostase do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular.
C) A nefropatia induzida por analgésicos/anti-inflamatórios ocorre por um excesso de deposição de metabólitos inativos destes medicamentos na membrana de filtração do glomérulo.
D) Todas as alternativas estão corretas.

40. Em relação ao tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), assinale a alternativa CORRETA.

A) Para a redução do volume prostático é indicado o uso de fármacos inibidores da enzima 5α redutase que é responsável pela hidrólise do hormônio di-hidrotestosterona. Desta forma ocorrerá uma redução na liberação de fatores de crescimento e aumento (consequentemente) da proliferação celular no tecido prostático.

B) O tratamento dos sintomas do trato urinário inferior na HPB é feito a partir da utilização dos antagonistas dos receptores α1-adrenérgicos, tendo como efeito principal o relaxamento do colo da bexiga e uretra prostática.

C) Os antagonistas dos receptores α1-adrenérgicos que possuem maior seletividade para os subtipos de receptores α1A e α1C, não apresentam os efeitos adversos de hipotensão ou ejaculação retrógrada.

D) Todas as alternativas estão corretas.

M1 - Megazord

1. Sobre a reabilitação nas patologias ortopédicas:

A) Atua no diagnóstico e tratamento das patologias ortopédicas, não sendo escopo de sua atuação a prevenção.
B) O objetivo final da reabilitação é devolver ao indivíduo o máximo de funcionalidade dentro do seu contexto.
C) No tratamento da Dor Crônica, o médico fisiatra utiliza apenas a prescrição de fisioterapia para melhora do paciente.
D) A reabilitação pós fratura só deve iniciar após cerca de 8-12 semanas, independente do local da fratura, gravidade, ou técnica utilizada na estabilização, tendo pouco benefício o início precoce.

2. Você é chamado para avaliar um paciente adulto no pronto socorro. No exame, o paciente apresenta uma grande queimadura no braço esquerdo e no tórax, envolvendo quase todo o membro superior esquerdo e metade do tronco anterior. Qual a sua estimativa para a extensão da queimadura?

A) 12%.
B) 18%.
C) 24%.
D) 28%.

3. Na displasia de desenvolvimento do quadril:

A) O teste de Barlow é uma manobra que detecta a luxação do quadril com a sua flexão e adução.
B) O teste de Galleazzi é sempre anormal, mesmo na presença dessa patologia nos quadris bilateralmente.
C) O suspensório de Pavlik deve ser usado mesmo em luxações teratológicas do quadril.
D) A redução cruenta associada à osteotomia de fêmur derrotativa e com encurtamento além de osteotomia de Salter, combinadas são indicadas em crianças de 12 meses de idade.

4. Um paciente com 6m de Trauma raquimedular apresenta-se com Babinsky, clônus de membros inferiores e reflexo de Hoffmann positivo. Qual a altura provável da lesão do paciente?

A) C4C5.
B) T8T9.
C) T12L1.
D) L4L5.

5. Paciente 18 anos, sexo feminino, foi vítima de acidente motociclístico, queixando-se de dor intensa em membro superior D, na região antebraço. No momento do exame físico pela equipe pré-hospitalar foi visto deformidade em antebraço. Paciente foi encaminhada ao Pronto Socorro de Ortopedia, realizado radiografia do antebraço e visualizado fratura de rádio e ulna na região diafisária com desvio. Foi indicado cirurgia, porém paciente terá que aguardar a vaga ser liberada, e por isso foi imobilizada. Qual o tipo de imobilização que deve ser usada:

A) Inguino-podálica.
B) Antebraquio-palmar.
C) Axilo-palmar.
D) Tóraco-braquial.

6. No exame físico de paralisia obstétrica alta encontramos:

A) Reflexo de Moro assimétrico.
B) Reflexo de preensão ausente.
C) Mão em garra.
D) Membro em rotação externa e supinação do antebraço.

7. Os seguintes sintomas estão presentes ao suspeitar de uma fratura:

I - dor local;
II - edema ou deformidade;
III - hematoma;
IV - crepitação ao movimentar ou incapacidade funcional do membro;
V - muita sede;
VI - temperatura alta.
Dos itens acima mencionados, os que são realmente identificados como presença de possível fratura:

A) I, IV.
B) I, IV, V, VI.
C) II, III, V, VI.
D) I, II, III, IV.

8. Em relação às fraturas expostas, marque a alternativa correta:

A) A classificação de Gustillo leva em consideração, principalmente, o tamanho do ferimento (até 1, de 1 a 10, maior de 10 cm).
B) Paciente trabalhador rural, apresentou queda do cavalo no curral com fratura da perna com ferimento de aproximadamente 4 cm ao nível da fratura. O seu diagnóstico é: fratura exposta da perna grau II de Gustillo.
C) A complicação mais temida na fratura exposta é a infecção e por isso é muito importante a limpeza e desbridamento desses ferimentos.
D) O tratamento da fratura exposta pode ser conservador, principalmente nos casos com mais de 6 horas de exposição.

9. Com relação à hora de ouro do ATLS, é correto afirmar que:

A) A melhora do tempo de resposta do resgate não influencia na sobrevida.
B) As mortes que ocorrem após a primeira semana do trauma decorrem principalmente do estado de choque.
C) A mortalidade aumenta em pacientes graves e internados por longos períodos devido a infecções.
D) Nenhuma das anteriores.

10. Você está descrevendo os riscos e benefícios da expansão tecidual para os pais de uma criança que apresenta uma área de alopecia no couro cabeludo. Qual das seguintes alternativas constitui a principal vantagem da expansão tecidual para esta criança?

A) O menor número de procedimentos com anestesia geral.
B) O menor número de consultas clínicas hospitalares.
C) O defeito pode fechar diretamente utilizando um retalho de pele com cabelo.
D) A reconstrução pode ser terminada rapidamente.

11. Dentro dos critérios de diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), em relação ao exame denominado FAN em células HEp-2, foram criados algoritmos nas reuniões de Consenso Nacional de Laudos de FAN (Dellavance e cols., mod. Rev Bras Reumatol., v. 47, n. 4, p. 265-275, jul/ago, 2007). CORRELACIONE AS COLUNAS (A e B) E ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA:

A) PADRÕES NUCLEARES EM CÉLULAS HEp-2:

I - Nuclear homogêneo periférico, placa metafásica cromossômica negativa, tipo membrana nuclear contínua.

II - Nuclear homogêneo, placa metafásica cromossômica positiva.

III - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica positiva, centromérico.

IV - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica positiva, pontilhado fino denso.

V - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica negativa, grosso.

VI - Nuclear pontilhado, placa metafásica cromossômica negativa, fino.

B) RELEVÂNCIAS CLÍNICAS POR AUTOANTICORPOS MAIS IMPORTANTES:

1 - Anticorpo anti-proteína p75 kDa, Ag LEDGF/p75 (lens epithelium-derived growth factor). Não está associado a doença autoimune. Pode ser encontrado na cistite intersticial, tumor de mama, processos inflamatórios inespecíficos; pode ser encontrado em indivíduos saudáveis, dermatite atópica, psoríase.

2 - Anticorpo anti-DNA nativo: lúpus eritematoso sistêmico (LES). Anticorpo anti-histona: LES induzido por drogas (hidralazina, procainamida, isoniazida e clorpromazina); LES idiopático. Anticorpo anti-cromatina (DNA/histona, nucleossomo): artrite reumatoide (AR); artrite idiopática juvenil, com importante associação com uveíte na forma oligoarticular; síndrome de Felty; cirrose biliar primária.

3 - Anticorpo anti-SSA/Ro: Ag - 4 pequenos RNAs associados a 2 proteínas de 60 e 52 kDa. (INCOMPLETO) parte da descrição clínica está cortada na fotografia.

Anticorpo anti-SSB/La: lúpus neonatal; LES; SS. Ag - proteína 48 kDa, parece ter função como fator terminal na transcrição da RNA polimerase III. Frequentemente associado a SSA/Ro, SS primária, lúpus neonatal, lúpus, púrpura, hipergamaglobulinemia, disfunção severa da glândula salivar, edema de parótida, altos níveis de fator reumatoide, linfopenia e leucopenia.

Anticorpo anti-Mi-2: dermatomiosite, embora raramente ocorra na polimiosite do adulto.

4 - Anticorpo anti-lamina, componente da membrana interna, pontos de ancoragem de cromossomos de células em interfase, pode ser encontrado nas hepatites autoimunes, raramente associado a doenças reumáticas (algumas formas de LES e esclerodermia linear, vasculite cerebral ou cutânea).

5 - Anticorpo anti-centrômero: esclerose sistêmica forma CREST (curso benigno e prolongado), esclerodermia (50 a 82%), cirrose biliar primária (8%).

6 - Anticorpo anti-Sm: 99% de especificidade para lúpus. Relação com doença ativa independente do título, relação mais frequente com acometimento do SNC, doença renal, fibrose pulmonar e pericardite.

Anticorpo anti-RNP: muitos casos associados a Sm. Critério obrigatório no diagnóstico da doença mista do tecido conjuntivo (DMTC - relaciona com altos títulos); também ocorre no LES (30 a 40%, doença menos severa), esclerose sistêmica (ES) e AR.

A SEQUÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CORRETA É:

A) I-4; II-2; III-1; IV-6; V-5; VI-3.

B) I-1; II-5; III-6; IV-4; V-3; VI-2.

C) I-4; II-1; III-5; IV-2; V-3; VI-6.

D) I-4; II-2; III-5; IV-1; V-6; VI-3.

12. Correlacione adequadamente as colunas, cada anticorpo com a doença em que ele mais frequentemente está positivo:

1. Anti-histonas 2. c-ANCA 3. Anti-RNP 4. Anti-DNA nativo 5. Anti-SSA/Ro

( ) Doença Mista do Tecido Conjuntivo.

( ) Nefrite Lúpica.

( ) LES induzido por drogas.

( ) Granulomatose com Poliangeíte - ex Granulomatose de Wegener.

( ) Síndrome de Sjögren.

A sequência correta está em:

A) 3,4,1,2,5.

B) 1,2,3,4,5.

C) 1,5,4,2,3.

D) 5,1,2,4,3.

13. Considerando o laboratório na análise das causas mais frequentes de anemias no idoso, analise as afirmações abaixo e depois escolha a sequência de afirmações corretas (verdadeiras).

I - O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de discriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferro.

II - O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de discriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferritina.

III - A Contagem de Reticulócitos é muito útil na diferenciação da Anemia Ferropriva da Anemia Megaloblástica, também importante causa de anemia no idoso.

IV - A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser solicitada quando estivermos diante de uma anemia microcítica e hipocrômica, com anisocitose.

A alternativa com as afirmações corretas (verdadeiras) é:

A) II e IV.

B) I, III e IV.

C) II, III e IV.

D) I e IV.

14. Uma paciente de 88 anos foi admitida no serviço de urgência com fraqueza como queixa principal. Apresentava dispneia, sintomas gastrointestinais como náuseas e vômitos, dor abdominal, dispepsia, prurido e feridas na boca há 3 dias. Os sintomas foram progressivos. Na avaliação dos medicamentos consumidos foi determinado que ela está em uso contínuo de metotrexato (MTX) há cerca de 5 meses. Na busca da causa do uso de MTX e checagem das prescrições, foi revelado que a paciente recebeu por engano MTX ao invés de digoxina. Ela havia usado MTX 1,25 mg por 5 meses consecutivos, e 2,5 mg cinco dias por semana no último mês. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que indica a melhor opção terapêutica a ser instituída:

A) A retirada do MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina).

B) A retirada do MTX e a administração de ácido fólico.

C) A retirada do MTX e a administração de vitamina E.

D) Continuação com MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina).

15. Um paciente com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, foi internado na Unidade Coronariana com angina instável. Apresentou, durante sua internação, quadro agudo de artrite na articulação metatarsofalangeana e tornozelo. Relatou que já havia sofrido quadro semelhante previamente. Considerando sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que melhor indica o diagnóstico de artrite e opção terapêutica a ser instituída.

A) Artrite reumatoide e Colchicina.

B) Gota e Alopurinol.

C) Gota e Anti-inflamatório não hormonal.

D) Gota e Corticosteroides.

16. Sobre a artrite reumatoide, julgue as alternativas e responda:

I - A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca a sinóvia e causa o acúmulo de líquido nas articulações, perda debilitante de cartilagem, fraqueza óssea e deformidade articular. É uma condição crônica e progressiva, podendo haver longos períodos de remissão (sem sintomas).

II - Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com metotrexato.

III - Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com um inibidor do fator de necrose tumoral (TNF) como monoterapia.

IV - Paciente com artrite reumatoide estabelecida em caso de falha da monoterapia inicial com um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), por exemplo metotrexato, é indicada uma terapia com a combinação dupla ou tripla de DMARD convencional (Metotrexato, leflunomida, sulfassalazina, cloroquina e hidroxicloroquina).

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

17. A respeito dos fármacos antirreumáticos modificadores da doença, julgue as alternativas e responda:

I - O metotrexato é um fármaco de primeira escolha, que tem atividade citotóxica e imunossupressora.

II - A tempo de ½ vida da leflunomida é reduzida pela interação medicamentosa com colestiramina A.

III - A ciclosporina inibe a atividade dos linfócitos T efetores CD8+.

IV - O tofacitinibe e o baricitibe são anticorpos monoclonais que inibem a via de sinalização JAK-STAT.

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

18. As bengalas são dispositivos auxiliares da marcha (DAM) e, também, consideradas como órteses de membros inferiores, utilizadas com várias finalidades, como para aumentar o equilíbrio durante a deambulação e reduzir a descarga de peso de um dos membros inferiores durante a fase de apoio da marcha. Assinale a alternativa que descreve forma correta de utilização de uma bengala para uma paciente com osteoartrite de joelho direito.

A) A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior contralateral.
B) A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro inferior homolateral.
C) A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior homolateral.
D) A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro inferior contralateral.

19. Sobre o Delirium ou estado confusional agudo em pacientes idosos, marque a alternativa correta:

A) Um dos instrumentos utilizados para o seu diagnóstico é o questionário CAM (Confusion Assessment Method).
B) É uma situação cada dia mais rara em idosos tendo em vista a elevada prevalência de doenças crônicas nesta população.
C) Caracteriza-se pela apresentação insidiosa e progressiva de déficits de memória, cálculo e linguagem.
D) A droga de escolha para o seu tratamento, independente se hiper ou hipoativo, é a administração de haloperidol por via endovenosa.

20. Uma senhora de 88 anos residente em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) e portadora de doença de Alzheimer em fase grave foi transferida para o hospital às 14 horas para tratamento de pneumonia aspirativa. No hospital, foi necessária sedação com haloperidol para início da antibioticoterapia venosa com ceftriaxona e clindamicina. No dia seguinte, por volta das 21 horas, a enfermeira do plantão, ao trocar a fralda da paciente, observou eritema persistente na região sacral sem perda de continuidade da pele. Que tipo lesão de pele essa paciente apresenta?

A) Dermatite de contato pelo uso de fralda.
B) Lesão por pressão estágio I.
C) Candidíase moderada pelo uso de antibióticos.
D) Alergia aos antibióticos iniciados.

21. Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (GDS) é um bom instrumento para o rastreamento de sintomas depressivos em idosos porque:

A) Permite a detecção de sintomas depressivos associados às demências.
B) Permite a diferenciação entre sintomas depressivos e a reação ao luto.
C) Não inclui perguntas sobre os sintomas somáticos da depressão.
D) Permite detectar aqueles que apresentam maior risco de suicídio.

ATENÇÃO: As questões 22 e 23 referem-se ao caso clínico:

A Senhora MASV, de 78 anos, é portadora de depressão, hipertensão arterial, osteoartrite de joelhos e diabetes com polineuropatia. Ela faz uso de três comprimidos ao dia de acordo com seguinte esquema terapêutico:

- 1 (um) comprimido pela manhã de formulação comercial que contém Olmesartana (bloqueador de receptor de angiotensina) 20 mg + Hidroclorotiazida (diurético tiazídico) 12,5 mg + Anlodipino (bloqueador dos canais de cálcio) 5 mg para tratamento da hipertensão arterial.
- 1 (um) comprimido à noite de formulação comercial que contém Metformina (biguanida) 1000 mg + Sitagliptina (Inibidor de DPP-4) 100 mg para tratamento da diabetes.
- 1 (um) comprimido à noite de Amitriptilina (antidepressivo tricíclico) 75 mg para a depressão e para dor.

Avaliação Geriátrica Ampla:

TGUG Teste: 25 segundos.

Barthel: 80 pontos (dificuldades para se vestir, incontinência ocasional e necessidade de supervisão para subir escadas).

Pfeffer: 13 pontos (dificuldades com manuseio do dinheiro, com os medicamentos, fazer compras, preparar comida, encontrar o caminho de volta para a casa e ficar só em casa por muito tempo).

MEEM: 23 pontos.

Fluência verbal semântica: 9 nomes de animais.

Teste do desenho do relógio: 1 ponto (escore de Shulman).

Escala de Depressão Geriátrica: 3 pontos.

APGAR da família: 10 pontos.

Mini Avaliação Nutricional: 11 pontos (risco de desnutrição).

Força de preensão manual: 21 kg.

DXA: Massa muscular esquelética apendicular dividida pela altura ao quadrado: 6,3 kg/m².

Hemograma, função renal, hepática e tireoidiana, vitamina B12, glicemia, lipidograma e eletrólitos: normais.

VDRL e anti-HIV: negativos.

Ressonância magnética do crânio: atrofia cerebral difusa compatível com a idade. Lobos temporais mediais e hipocampos preservados. Discreta microangiopatia.

22. Sobre o esquema terapêutico, pode-se afirmar que a Sra. MASV:

A) Tem polifarmácia e faz uso de uma medicação considerada inapropriada para idosos.
B) Não tem polifarmácia e não faz uso de medicação considerada inapropriada para idosos.
C) Não tem polifarmácia, pois usa 3 comprimidos ao dia, mas faz uso de medicação inapropriada para idosos.
D) Tem polifarmácia, mas não faz uso de medicação considerada inapropriada para idosos.

23. Ainda sobre o caso clínico da Sra. MASV, com relação às suas doenças, pode-se afirmar que:

A) Ela não tem multimorbidade, mas tem uma complicação de doença crônica.
B) Ela tem multimorbidade complexa e apresenta uma complicação de doença crônica.
C) Ela tem apenas multimorbidade, sem nenhuma complicação de doença crônica.
D) Ela tem uma doença índice, várias comorbidades e uma complicação de doença crônica.

ATENÇÃO: As questões 24, 25, 26 e 27 referem-se ao caso clínico:

O senhor JPC, de 77 anos, engenheiro aposentado, é portador de hipertensão arterial e diabetes. Faz uso de Losartana, Glicazida e Metformina. Familiares relatam que há 6 meses vem apresentando quedas frequentes, lentidão para deambular, postura encurvada e rígida, tremores nas mãos, recusa alimentar, tosse ao ingerir líquidos e perda de peso. Além disso, sua memória está ruim, alternando períodos de muita lucidez e períodos de confusão nos quais relata que tem uma família com três crianças vivendo na área de serviço do apartamento. Nada o demove disso, descreve a aparência das crianças e chega a levar suco e doces para elas. Ele apresenta os seguintes resultados na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) e de exames:

24. De acordo com a história clínica, a avaliação cognitiva e funcional da AGA e exames pode-se afirmar que o Sr. JPC tem:

A) Provável demência vascular.
B) Possível demência da doença de Parkinson.
C) Provável demência com corpos de Lewy.
D) Possível demência frontotemporal variante comportamental.

25. Sobre a função muscular do Sr. JPC é correto afirmar que ele:

A) Não tem sarcopenia, pois as quedas, a lentidão e as dificuldades de mobilidade são explicadas pelo quadro neurocognitivo.
B) Tem provável sarcopenia, mas isso já indica o início de medidas terapêuticas e de reabilitação.
C) Tem sarcopenia, pois a força muscular está diminuída e o paciente apresentou quedas repetidas.
D) Tem sarcopenia grave confirmada pelas alterações da força, massa e desempenho musculares.

26. Com os dados da história e da AGA, aplique a escala clínica de fragilidade para o Sr. JPC.

A) Em terminalidade - 9.
B) Moderadamente frágil - 6.
C) Levemente frágil - 5.
D) Não frágil, mas regular - 3.

27. A AGA é útil não só para o diagnóstico de deficiências e incapacidades, mas pode contribuir para o diagnóstico etiológico, ou seja, das doenças, como também é importante para definição do plano terapêutico e dos profissionais da equipe multidisciplinar necessários. Em um cenário do SUS, com dificuldades de acesso a equipes multidisciplinares, e baseando-se nos dados da AGA, para quais profissionais você encaminharia, inicialmente, o senhor JPC visando a manutenção por mais tempo de sua capacidade funcional.

A) Fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista.
B) Neuropsicólogo, fisioterapeuta e massagista.
C) Nutricionista, enfermeiro e educador físico.
D) Fisioterapeuta, educador físico e reeducador postural.

28. Assinale a sequência correta: Escolha V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas em relação à artrite reumatoide.

( ) A rigidez matinal e os nódulos de Heberden são critérios de diagnóstico.
( ) O padrão de envolvimento articular mais frequente é a poliartrite de pequenas articulações.
( ) A glicosamina e a condroitina são as drogas de escolha para prevenir as erosões.
( ) O fator reumatoide contribui para o diagnóstico e em altos títulos indica pior prognóstico.

A) V, V, F, F.
B) F, V, F, V.
C) F, V, F, F.
D) V, F, V, F.

29. Em relação à espondilite anquilosante é correto afirmar:

I - A presença do HLA B27 aumenta o risco para espondilite anquilosante.
II - Os osteófitos e a redução do espaço vertebral na coluna lombar são achados radiográficos característicos.
III - A uveíte anterior é uma das manifestações extra articulares.
IV - Os pacientes apresentam lombalgia que melhora com movimento associada a rigidez matinal.

A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) I, II e IV.
D) I, III e IV.

30. Sobre a gota assinale a alternativa correta:

A) O uso de ácido acetilsalicílico em altas dose em pessoas com hiperuricemia pode aumentar o risco de artrite aguda.
B) Classicamente se manifesta como monoartrite aguda, que se instala rapidamente em poucas horas com dor intensa e sinais flogísticos na articulação acometida.
C) É importante fazer a medida do ácido úrico sérico logo no início da crise, para iniciar o hipouricemiante imediatamente.

D) Apesar de poder manifestar-se como crises repetidas de artrite, não provoca alterações permanentes nas articulações.

31. Um mulher de 18 anos procura assistência médica com queixa de eritema malar, fotossensibilidade, úlceras incolores no palato duro, anorexia e artrite nos joelhos há 1 mês. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, qual o achado laboratorial encontrado?

A) Leucocitose com desvio à esquerda.
B) Diminuição de C3 e C4.
C) Presença de anti SCL 70.
D) Fator reumatoide positivo.

32. Os corticosteroides são medicamentos de ação anti-inflamatória e imunossupressora. São utilizados para suprimir os mecanismos de resposta imune, procedimento necessário para realizar o tratamento das doenças reumáticas imunomediadas. Sobre tais drogas, é correto afirmar:

A) Deve-se evitar a prescrição de prednisona em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa.
B) Pacientes em uso prolongado de altas doses de corticosteroides devem ser monitorizados quanto ao risco de hipoglicemia e hipotensão.
C) A prescrição de carbonato de cálcio e da vitamina D é indicada na prevenção de osteoporose cortico-induzida.
D) A ação mineralocorticoide e a potência da prednisolona, prednisona, metilprednisolona e dexametasona são idênticas.

33. Paciente de 24 anos comparece para consulta na UBS com queixas de “azia e queimação no estômago”. Durante a anamnese você descobriu que essa paciente utilizava nimesulida, três vezes por semana, há quatro meses, em função de dor lombar mecânico postural. Podemos justificar esta sintomatologia dada a ação dos AINES inibindo a:

A) COX-1.
B) COX-2.
C) Fosfodiesterase.
D) Dihidroorato redutase.

34. J.M.S., 56 anos, sexo feminino, católica, parda, casada, atendente de telemarketing, procedente e residente em Goiânia, apresenta como queixa principal: “Dor intensa no corpo todo e fadiga há 4 meses”. Ela afirma que vinha bem quando, há 4 meses, iniciou quadro de dor em região lombar, MMSS e MMII, bilateral, de intensidade moderada (5 em uma escala de 0-10), insidiosa, caracterizando essa dor como difusa nos membros acometidos. Refere que, há 3 meses, evoluiu com dor generalizada em todo corpo, de forma constante e de mesma intensidade, associada a fadiga, principalmente após esforço físico, cefaleia, depressão e obstipação intestinal. No exame físico não havia artrite, observando-se dor à palpação da musculatura de todo o corpo. Exames laboratoriais: TSH, VHS e PCR normais, com o fator reumatoide negativo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta mais adequada é prescrever:

A) Prednisona.
B) Etoricoxibe.
C) Metotrexato.
D) Pregabalina.

35. A osteoporose é a doença metabólica mais frequente na população geral, afetando sobretudo mulheres pós-menopausa e homens idosos. Assinale os medicamentos cujo uso crônico se associa a um risco aumentado desta condição:

A) Hidroclorotiazida, heparina e carbamazepina.
B) Deflazacorte, heparina e carbamazepina.
C) Hidroclorotiazida, heparina e carbamazepina.
D) Deflazacorte, heparina e carisoprodol.

36. A osteoartrite é uma doença articular crônica, caracterizada por insuficiência cartilaginosa secundária a fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos. Sobre a fisiopatologia desta doença, é correto afirmar:

A) Os condrócitos são a maior fonte de enzimas degradadoras, sintetizando e ativando proteases, as quais atuam no catabolismo da cartilagem.
B) O fator de crescimento fibroblástico e o fator de crescimento insulínico desempenham importante papel na síntese de proteases.
C) Uma vez ativados, os condrócitos produzem óxido nítrico, o qual exerce vários efeitos anabólicos, aumentando a síntese de proteoglicanos.
D) A diminuição do ativador de plasminogênio e o aumento do nível do inibidor da atividade de plasminogênio (PAI-1) são os responsáveis pela maior produção de plasmina, a qual ativa a colagenase.

37. Mulher de 60 anos, profissão de bordadeira, antecedente de hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2, em uso regular de Puran T4 125 mcg/dia e Metformina 500 mg, 2 vezes/dia, menopausada há três anos, refere dor tipo queimação, dormência, sensação de edema e congestão das mãos e perda da habilidade manual em ambas as mãos, de início há dois anos e piora considerável nos últimos seis meses. Ao exame físico, apresenta teste de Tinel positivo, bilateralmente, e atrofia tenar, principalmente à direita; ausência de sinais de artrite em punhos e articulações das mãos. Considerando-se a principal hipótese diagnóstica para o caso, a sintomatologia bilateral pode ser explicada pelos seguintes fatores:

A) Idade da paciente e profissão laboral.
B) Antecedente de hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2.
C) Profissão laboral e gênero feminino.
D) Idade da paciente e antecedente de menopausa.

38. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, cor branca e residente em Goiânia. Procurou médico por apresentar cinco nódulos na coxa direita. Ao exame por imagem os nódulos medem em média 5,0 cm cada um, são superficiais e não apresentam envolvimento neurovascular. O diagnóstico mais provável é:

A) (INCOMPLETO) início do nome da alternativa cortado; termina em “oma”.
B) Hemangioma.
C) Rabdomiossarcoma embrionário.
D) Sarcoma pleomórfico alto grau.
E) Osteoma.

39. Em relação aos tumores malignos de partes moles (sarcomas) podemos afirmar:

A) As metástases são geralmente para linfonodos.
B) A ressonância magnética é bastante precisa no diagnóstico etiológico.

C) São mais frequentes em crianças do que em idosos.
D) Localização em retroperitônio é associada a pior prognóstico.

40. São consideradas indicações para biópsia de um tumor de partes moles:

A) Crescimento rápido, com dor e rubor locais.
B) Tamanho maior que 5 cm e evidência de crescimento progressivo.
C) Surgimento e após trauma em paciente com história familiar de sarcoma.
D) Lesão em proximidades de uma grande articulação.

41. São características do estudo radiográfico, EXCETO:

A) Método multiplanar.
B) Utiliza radiação ionizante.
C) Deve ser realizado preferencialmente em pelo menos duas incidências.
D) Acessível.

42. Quais os métodos de imagem mais utilizados atualmente no estudo das afecções osteoarticulares?

A) Radiografia, Bursografia, Cintilografia Óssea e Ressonância Magnética.
B) Ultrassonografia, Tomografia computadorizada, Ressonância Magnética e Discografia.
C) Tomografia computadorizada, Mielografia, Radiografia e Ressonância Magnética.
D) Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética.

43. Estreitamento localizado do espaço articular, esclerose subcondral, osteófitos marginais e cistos subcondrais são achados de imagem comumente vistos em:

A) Osteoartrite.
B) Artrite Psoriásica.
C) Artrite Reumatoide.
D) Gota.

Gabarito comentado

Provão M2 e M1 - dezembro de 2022 | 83 questões | 40 M2 + 43 M1

Critério editorial: as 19 páginas originais foram preservadas. As respostas são independentes de eventual marcação preexistente. Em itens sem informações suficientes, consta “sem resposta segura”; em respostas convencionais que não correspondem a regra clínica absoluta, consta ressalva.

Importante: as interpretações priorizam precisão clínica e diretrizes em vigor, sem reconstruir enunciados ilegíveis. Questões clínicas não substituem decisão médica individualizada. As referências aparecem identificadas por [Rxx] no comentário e completas ao final.

Gabarito resumido - M2: Urologia e Nefrologia

01. SEM GABARITO	**02.** A	**03.** C	**04.** A
05. E	**06.** B	**07.** SEM GABARITO	**08.** E
09. C	**10.** D	**11.** A	**12.** C
13. E	**14.** C	**15.** A	**16.** SEM GABARITO
17. B	**18.** C	**19.** B	**20.** D
21. E	**22.** C	**23.** SEM GABARITO	**24.** C
25. B	**26.** D	**27.** B	**28.** D
29. B	**30.** A	**31.** D	**32.** B
33. C	**34.** C	**35.** C	**36.** A
37. C	**38.** A	**39.** B	**40.** B

Gabarito resumido - M1: Reumatologia, Ortopedia e áreas correlatas

01. B	**02.** B	**03.** A	**04.** A
05. C	**06.** A	**07.** D	**08.** C
09. C	**10.** C	**11.** D	**12.** A
13. A COM RESSALVA	**14.** A	**15.** D	**16.** C COM RESSALVA
17. B COM RESSALVA	**18.** D	**19.** A	**20.** B
21. C	**22.** A	**23.** B	**24.** C
25. SEM GABARITO	**26.** SEM GABARITO	**27.** A	**28.** B
29. D	**30.** B	**31.** B	**32.** C

33. A	**34.** D	**35.** B	**36.** A
37. B	**38.** SEM GABARITO	**39.** D	**40.** B
41. A	**42.** D	**43.** A	

Pontos que exigem atenção especial

M2: questões 1, 7, 16 e 23 sem gabarito conclusivo; 3, 9, 13, 15, 18, 20, 33 e 38 com ressalvas técnicas ou redação pouco precisa. **M1:** questões 25, 26 e 38 sem gabarito conclusivo; questões 3, 8, 13, 16, 17 e 24 exigem ressalvas.

Gabarito comentado - M2 - Urologia e Nefrologia

Cada alternativa é examinada individualmente. As justificativas referem-se à redação efetivamente presente na prova.

QUESTÃO 01 | SEM RESPOSTA SEGURA

O verbo e o sentido da pergunta foram cortados: não é possível estabelecer qual cadeia linfonodal se pretende identificar.

A) Os inguinais profundos não constituem a drenagem habitual principal da próstata; sem o comando completo não é possível julgá-los como resposta.

B) Os pré-sacrais podem participar da drenagem prostática, mas falta saber se a pergunta pede via secundária ou excepcional.

C) Os inguinais superficiais recebem predominantemente linfa de pele e genitália externa, não são via usual prostática.

D) Linfonodos retroperitoneais podem surgir em disseminação mais avançada, sem serem a primeira estação habitual.

E) Linfonodos hilares renais não são a drenagem habitual da próstata.

Ressalva: enunciado incompleto; nenhuma letra foi atribuída.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 02 | A

A principal limitação da uretrotomia interna, sobretudo na uretra peniana, é a alta recorrência da estenose.

A) Correta: reestenose é o evento mais frequente e pode exigir nova abordagem ou uretroplastia.

B) Hemorragia pode ocorrer, mas é menos frequente que recidiva.

C) Extravasamento é complicação técnica possível, não a mais comum.

D) Disfunção erétil é possível, porém não é o principal desfecho.

E) Fístula espongiocavernosa é rara, não a complicação usual.

Referências relacionadas: [R07].

QUESTÃO 03 | C

A técnica bipolar utiliza solução salina e reduz risco de síndrome de absorção de irrigante; entre as opções, menor sangramento é a melhor aproximação.

A) Estenose de colo pode ocorrer com ambas; não é a distinção principal.

B) A vantagem não é redução comprovada e predominante de disfunção erétil.

C) Mais apropriada entre as opções: há evidência de redução de sangramento/transfusão em alguns cenários.

D) Estenose de uretra também pode ocorrer na técnica bipolar.

E) Não há redução consistente de incontinência que defina a diferença.

Ressalva: a vantagem clássica mais característica, menor risco de síndrome da RTU, não consta das alternativas.

Referências relacionadas: [R06].

QUESTÃO 04 | A

DPOC aumenta a vulnerabilidade à retenção de CO_2 durante e após pneumoperitônio laparoscópico.

A) Correta: reserva ventilatória reduzida requer monitorização e, em situações selecionadas, gasometria.

B) Asma leve controlada isolada não implica a mesma retenção persistente de CO_2.

C) Insuficiência cardíaca pode exigir cuidados, mas não é o principal exemplo de risco ventilatório específico.

D) Duração longa pode aumentar absorção de CO_2, sem indicar gasometria tardia de rotina para todos.

E) Cirurgia renal não determina, por si só, controle gasométrico após anestesia.

Ressalva: duração exata do enunciado ilegível; exame depende da evolução clínica.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 05 | E

Entre os sítios elencados, o câncer peniano é geralmente o menos frequente em números absolutos, mas a comparação depende de população e tempo após transplante.

A) Tumores hepáticos podem ocorrer, sobretudo em contextos virais, e não são evidentemente os mais raros.

B) Câncer renal é relevante em receptores de transplante, inclusive nos rins nativos.

C) Carcinoma urotelial vesical pode ocorrer em transplantados.

D) Câncer prostático é relativamente comum na população masculina idosa.

E) Mais provável: neoplasia peniana é relativamente rara, embora HPV e imunossupressão aumentem seu risco.

Ressalva: pergunta epidemiológica imprecisa, sem taxas ou população de referência.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 06 | B

Glândulas prostáticas pequenas e atípicas podem demandar imuno-histoquímica para avaliar ausência de células basais.

A) Rebiópsia imediata não é automaticamente indicada antes de esclarecimento anatomopatológico.

B) Correta: marcadores de células basais e AMACR auxiliam na distinção entre benignidade e adenocarcinoma.

C) RM pode ajudar na investigação futura, mas não substitui esclarecer o foco atípico na lâmina.

D) Não há indicação universal de repetir biópsia em exatamente dois meses.

E) A prostatectomia exige diagnóstico e estadiamento adequados, não apenas atipia focal.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 07 | SEM RESPOSTA SEGURA

O início do enunciado não esclarece se pede a exceção; além disso, beta-3 agonistas modernos podem causar hipertensão.

A) Boca seca é adversidade típica dos antimuscarínicos vesicais.

B) Constipação é efeito anticolinérgico comum.

C) Antimuscarínicos podem agravar glaucoma de ângulo fechado não controlado; não é risco universal para todo glaucoma.

D) Hipertensão não é clássica dos antimuscarínicos, mas pode ocorrer com mirabegrona.

E) Alterações cognitivas podem surgir com anticolinérgicos, sobretudo nos idosos.

Ressalva: texto truncado e classe terapêutica não delimitada; se pergunta por exceção aos antimuscarínicos, D é a resposta convencional.

Referências relacionadas: [R06].

QUESTÃO 08 | E

Em lesão retal durante prostatectomia de resgate após irradiação, a proteção com derivação fecal pode ser considerada dada a elevada morbidade.

A) Reparo primário isolado pode ser insuficiente em tecidos irradiados.

B) Colostomia sem reparar a perfuração não resolve adequadamente a lesão identificada.

C) Sonda retal não substitui proteção fecal quando esta é indicada.

D) Interromper e bloquear hormônios não é tratamento padrão da lesão retal intraoperatória.

E) É a estratégia mais protetora entre as opções: fechamento e colostomia de proteção.

Ressalva: a decisão por estoma depende de extensão, contaminação e viabilidade tecidual; não é universal.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 09 | C

Idade elevada, tabagismo e hematúria exigem investigação urológica, incluindo avaliação da bexiga.

A) Os fatores de risco não definem uma origem glomerular.

B) Também não identificam sangramento especificamente calicial.

C) Correta: cistoscopia integra a investigação do risco de câncer urotelial.

D) Citologia pode ser adjuvante em situações selecionadas, não substitui cistoscopia.

E) É literalmente verdade que esses dados não localizam o sangramento, mas não expressa a conduta clínica pedida.

Ressalva: a redação permite ler E como fato verdadeiro; C é a conduta prioritária.

Referências relacionadas: [R04].

QUESTÃO 10 | D

Risco de câncer urotelial associa-se a tabaco, radiação e exposições ocupacionais; história familiar de hematúria inespecífica não o define.

A) Tabagismo é importante fator de risco.

B) Radioterapia pélvica prévia aumenta risco de neoplasia vesical.

C) Alguns corantes, sobretudo aminas aromáticas, são fatores ocupacionais de risco.

D) Correta: história de hematúria familiar, por si só, não equivale a história familiar de câncer.

E) Idade continua importante, embora o ponto de corte de 35 anos seja antigo e impreciso.

Ressalva: a diretriz AUA 2025 usa estratificação por idade/sexo e outros fatores, não corte isolado de 35 anos.

Referências relacionadas: [R04].

QUESTÃO 11 | A

A maior parte dos adenocarcinomas prostáticos surge na zona periférica.

A) Correta: zona periférica é o sítio habitual do adenocarcinoma.

B) Zona de transição associa-se principalmente à hiperplasia benigna.

C) Zona central é sítio menos frequente de câncer.

D) Região periuretral não é a origem predominante do câncer.

E) Estroma fibromuscular anterior não corresponde à origem habitual do adenocarcinoma.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 12 | C

Lesões de Hunner são achado típico do fenótipo ulcerativo de síndrome da dor vesical/cistite intersticial.

A) Cistite eosinofílica é doença histológica distinta.

B) Cistite glandular designa metaplasia glandular, não a lesão de Hunner.

C) Correta: lesão inflamatória característica de cistite intersticial com lesão de Hunner.

D) Cistite cística corresponde a alterações epiteliais benignas.

E) Cistite tuberculosa causa outro padrão de lesões inflamatórias.

Referências relacionadas: [R06].

QUESTÃO 13 | E

Na avaliação inicial do risco prostático, PSA e toque retal se complementam; diagnóstico definitivo de câncer exige histologia.

A) Toque isolado perde tumores não palpáveis.

B) PSA isolado não é específico para câncer e não confirma o diagnóstico.

C) RM multiparamétrica é valiosa na avaliação pré-biópsia, mas não é confirmação isolada.

D) Ultrassom transretal isolado tem sensibilidade insuficiente para confirmar neoplasia.

E) Melhor opção de avaliação clínica inicial entre as ofertadas, sem dispensar RM e biópsia quando indicadas.

Ressalva: nenhum desses exames isoladamente confirma câncer; a pergunta confunde avaliação inicial com diagnóstico definitivo.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 14 | C

Em câncer de próstata localizado de muito baixo risco, vigilância ativa é conduta preferencial para quem tem expectativa de vida apropriada.

A) Prostatectomia pode causar efeitos adversos sem benefício proporcional em muitos casos de risco muito baixo.

B) Radioterapia é tratamento ativo frequentemente dispensável nesse estrato.

C) Correta: vigilância ativa estruturada com PSA, imagem e reavaliações.

D) Quimioterapia não é tratamento de primeira linha da doença localizada de risco muito baixo.

E) Hormonioterapia isolada não é indicada nessa situação.

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 15 | A

Após prostatectomia radical, disfunção erétil é sequela frequente, relacionada à preservação neurovascular e ao estado prévio.

A) Melhor alternativa se a cirurgia referida for prostatectomia radical.

B) Incontinência urinária é relevante, mas muitas vezes menos prevalente que disfunção erétil persistente.

C) Incontinência fecal não é complicação habitual.

D) Fístulas urinárias são complicações menos comuns.

E) Hematúria não é a principal complicação funcional crônica.

Ressalva: 'cirurgia de próstata' é inespecífico; a resposta depende do procedimento (radical, RTU etc.).

Referências relacionadas: [R05].

QUESTÃO 16 | SEM RESPOSTA SEGURA

O caso clínico e três alternativas estão ilegíveis. Não é possível estabelecer hipótese etiológica sem acrescentar fatos.

A) Diplococos Gram-negativos sugeririam gonococo, mas o texto preservado não permite associá-los à doença.

B) Alternativa ausente, impossível julgar.

C) Alternativa ausente, impossível julgar.

D) Alternativa ausente, impossível julgar.

Ressalva: item irrecuperavelmente incompleto na fonte fornecida.

QUESTÃO 17 | B

Edema, proteinúria intensa, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e cilindros gordurosos caracterizam síndrome nefrótica; autoimunidade sugere LES.

A) Síndrome nefrítica pode cursar com hematúria, mas não explica tão bem o conjunto nefrótico.

B) Correta: síndrome nefrótica com provável nefropatia lúpica; requer quantificação e investigação específica.

C) Há hematúria concomitante, porém predomina o padrão nefrótico.

D) Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa não é a hipótese etiológica mais provável.

Ressalva: dosagem de proteína em mg/dL isolada não substitui quantificação; albumina provavelmente em g/dL, apesar da unidade textual.

Referências relacionadas: [R02], [R03].

QUESTÃO 18 | C

NGAL é biomarcador precoce de dano tubular, mas diagnóstico formal de LRA ainda se baseia em creatinina e diurese.

A) Ácido úrico não serve como marcador específico precoce de LRA.

B) Ureia sofre influência de catabolismo e volemia e não é o melhor marcador precoce.

C) Correta apenas no sentido de biomarcador precoce entre as opções; não é exame universalmente recomendado na rotina.

D) BUN equivale ao nitrogênio ureico e partilha limitações da ureia.

Ressalva: biomarcador NGAL não substitui critérios KDIGO nem é indicado rotineiramente para todo paciente séptico.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 19 | B

O maior risco no mapa KDIGO decorre da combinação de TFG muito reduzida e albuminúria muito elevada.

A) G2A1 costuma corresponder a categoria prognóstica baixa se não há outros marcadores de dano.

B) Correta: G5A3 combina falência renal e albuminúria intensamente aumentada.

C) G4A2 é alto risco, inferior a G5A3 em geral.

D) G3A3 também tem risco importante, mas menor que G5A3 no mapa.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 20 | D

A CKD-EPI 2021 sem variável racial é opção recomendada para adultos quando se usa creatinina sérica.

A) Cockcroft-Gault estima depuração de creatinina, útil para doses, mas não é padrão de classificação da TFG.

B) CKD-EPI é uma família de equações e pode abranger 2021, tornando a opção genericamente verdadeira.

C) MDRD tende a ter pior acurácia em faixas altas da TFG.

D) Mais específica: versão CKD-EPI 2021 sem raça, com cistatina C quando disponível e indicado.

E) Schwartz é aplicada sobretudo à população pediátrica.

Ressalva: B e D se sobrepõem; D é a resposta específica mais adequada.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 21 | E

Em pediatria, equações de Schwartz e variantes pediátricas são as tradicionais para estimar TFG.

A) Cockcroft-Gault não é a equação pediátrica usual.

B) CKD-EPI convencional é desenvolvida para adultos.

C) MDRD não é padrão para crianças.

D) CKD-EPI 2021 para adultos não é a primeira escolha pediátrica.

E) Correta: Schwartz, com variações conforme disponibilidade de creatinina e cistatina C.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 22 | C

Doença por lesões mínimas envolve disfunção dos podócitos e apagamento difuso dos pedicelos.

A) Endotélio não é a célula primariamente afetada.

B) Mesângio não é sede primária do defeito.

C) Correta: podócitos são o alvo funcional central.

D) Alternativa D não aparece no arquivo, impossibilitando julgamento.

E) Histiócitos não explicam o padrão de lesão mínima.

Ressalva: ausência de alternativa D é da fonte original.

Referências relacionadas: [R03].

QUESTÃO 23 | SEM RESPOSTA SEGURA

Nenhuma proposição descreve corretamente, sem ressalvas, o mecanismo histológico da glomerulonefrite citada.

A) Depósitos pós-infecciosos são granulares em paredes capilares e mesângio, não simplesmente na luz capilar.

B) Anticorpo anti-membrana basal corresponde à doença anti-GBM, não à lesão mínima.

C) ANCA associa-se sobretudo à glomerulonefrite pauci-imune, não à membranosa.

D) GN pós-estreptocócica apresenta depósitos subepiteliais em gibas; apagamento podocitário difuso não é seu critério definidor.

Ressalva: D é a menos distante em termos de depósito imunológico, mas não constitui correlação correta como escrita.

Referências relacionadas: [R03].

QUESTÃO 24 | C

Hematúria, cilindros hemáticos, hipertensão grave, disfunção renal e autoanticorpos sugerem nefrite lúpica proliferativa com síndrome nefrítica.

A) Membranosa idiopática costuma ter padrão nefrótico sem sinais fortes de LES ativo.

B) GESF não explica satisfatoriamente consumo de complemento e anti-DNA.

C) Correta como hipótese: síndrome nefrítica por nefrite lúpica proliferativa; a classe depende de biópsia.

D) Anti-GBM exigiria suspeita clínica e testes próprios, sem evidência presente.

Ressalva: a hipertensão de 220/140 com congestão pulmonar é urgência clínica.

Referências relacionadas: [R02], [R03].

QUESTÃO 25 | B

Espículas à prata e anti-PLA2R positivo favorecem nefropatia membranosa primária.

A) Lesão mínima mostra glomérulos quase normais à óptica e apagamento podocitário à eletrônica.

B) Correta: depósitos subepiteliais geram espículas e anti-PLA2R é marcador importante.

C) GESF mostra esclerose segmentar focal, não espículas típicas.

D) Membranosa secundária exige investigar outras etiologias; anti-PLA2R apoia fortemente forma primária.

Ressalva: anticorpo positivo não afasta absolutamente causas associadas.

Referências relacionadas: [R03].

QUESTÃO 26 | D

HIV não controlado associa-se classicamente à nefropatia por HIV com GESF colapsante.

A) Lesão mínima não é a apresentação clássica de nefropatia associada ao HIV.

B) Membranoproliferativa pode ocorrer, inclusive por coinfecções, mas não é o protótipo.

C) Nefropatia por IgA não é o achado característico pedido.

D) Correta: variante colapsante de glomeruloesclerose segmentar e focal.

Referências relacionadas: [R03].

QUESTÃO 27 | B

Alteração de função renal persistente por quatro meses satisfaz o critério de duração de DRC, desde que corroborada a cronicidade.

A) LRA implica mudança em horas ou dias, não apenas creatinina elevada crônica.

B) Correta: função renal persistentemente alterada por mais de três meses sugere DRC.

C) Creatinina de 4 mg/dL não é normal no contexto fornecido.

D) Doença renal aguda corresponde a menos de três meses, salvo superposição com DRC.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 28 | D

A progressão da doença renal diabética até falência renal ocorre apenas em parcela dos indivíduos com diabetes.

A) Albuminúria A2 corresponde a 30-300 mg/g, não acima de 300 mg/g.

B) Hiperfiltração pode ocorrer em fases iniciais da nefropatia diabética.

C) Hialinose diabética pode atingir arteríolas aferentes e eferentes.

D) Correta: somente parte dos diabéticos evolui até estágios finais.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 29 | B

Em adulto com múltiplos cistos bilaterais, DRPAD é hipótese epidemiológica principal, a depender do padrão imagiológico.

A) Esclerose tuberosa pode cursar com cistos e angiomiolipomas, mas é menos frequente.

B) Correta: doença renal policística autossômica dominante predomina nessa apresentação.

C) Rim em esponja medular gera ectasia ductal, não padrão clássico de numerosos cistos corticais.

D) Forma recessiva apresenta-se predominantemente na infância.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 30 | A

Na fase aguda do grande queimado, perdas de fluido e resposta neuro-hormonal podem produzir hipovolemia e hiponatremia.

A) Melhor opção na apresentação inicial por perda de sódio e água com retenção relativa de água.

B) Hipernatremia hipervolêmica não é alteração predominante esperada.

C) Hiponatremia hipervolêmica não caracteriza habitualmente a fase inicial de choque do queimado.

D) Hipernatremia hipovolêmica pode surgir por perda de água livre e na evolução, mas não é a única possível.

Ressalva: distúrbios variam conforme fase, reposição e extensão da queimadura.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 31 | D

Oligúria/anúria na necrose tubular aguda associa-se, em geral, a maior gravidade do que formas não oligúricas.

A) Maior estágio KDIGO costuma correlacionar-se com pior prognóstico, não melhor.

B) Disfunção multiorgânica reduz, não aumenta, a sobrevida.

C) Não cabe afirmar menor sobrevida de LRA pré-renal em comparação com necrose tubular.

D) Correta: anúria costuma sinalizar lesão renal mais grave.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 32 | B

Insuficiência renal avançada oligúrica reduz excreção de potássio, favorecendo hipercalemia.

A) Hipernatremia não é achado invariável e em uremia pode haver hiponatremia.

B) Correta: retenção de potássio e acidose aumentam o risco.

C) Acidose metabólica é mais provável do que alcalose.

D) Retenção de magnésio é mais plausível que hipomagnesemia.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 33 | C

Anemia da DRC decorre sobretudo de deficiência relativa de eritropoetina, inflamação e desregulação do ferro; essa causa não foi listada.

A) Ligação às meta-hemoglobinas não explica a anemia típica da DRC.

B) Inflamação renal costuma aumentar hepcidina, não diminuir sua liberação.

C) É contributiva possível: AINEs podem causar sangramento digestivo e agravar função renal, mas não são a causa principal usual.

D) Intoxicação por B12 não é causa habitual de anemia renal.

Ressalva: questão mal formulada: falta a alternativa 'deficiência de eritropoetina'.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 34 | C

Síndrome cardiorrenal tipo 1 é a disfunção renal desencadeada por evento cardíaco agudo.

A) Rim agudo comprometendo o coração define síndrome tipo 3.

B) Doença sistêmica afetando ambos relaciona-se ao tipo 5.

C) Correta: insuficiência cardíaca/lesão cardíaca aguda leva à LRA.

D) Rim crônico comprometendo coração corresponde ao tipo 4.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 35 | C

Para candidatos apropriados, transplante renal oferece vantagem de sobrevida versus permanecer em diálise.

A) Diálise peritoneal não proporciona vantagem universal sobre hemodiálise.

B) Diabetes costuma associar-se a maior risco do que certas glomerulopatias, sem sobrevida igual garantida.

C) Correta: transplante apresenta melhor sobrevida média em candidatos adequados.

D) Transplante com doador vivo geralmente tem resultados melhores que com falecido.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 36 | A

Intoxicação por alumínio é causa clássica de doença óssea de baixo remodelamento e osteomalácia na DRC avançada.

A) Correta em cenário histórico de exposição ao alumínio por dialisato ou quelantes.

B) Hiperparatireoidismo tende a produzir osteíte fibrosa, não osteomalácia clássica.

C) Excesso de vitamina D costuma causar hipercalcemia/baixo turnover, não ser a causa típica descrita.

D) Deficiência de cálcio pode influenciar mineralização, porém isoladamente não define a osteomalácia urêmica.

> **Ressalva:** outras causas contemporâneas incluem deficiência de vitamina D e distúrbios da mineralização; não é exclusivamente por alumínio.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 37 | C

Furosemida bloqueia o cotransportador NKCC2 no ramo ascendente espesso da alça de Henle.

A) Não inibe diretamente a Na/K-ATPase basolateral.

B) Não tem como alvo primário o canal luminal de potássio ROMK.

C) Correta: inibição do Na-K-2Cl luminal promove natriurese e diurese.

D) Alteração paracelular ocorre secundariamente à perda do potencial, não é o alvo primário.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 38 | A

Com hipertensão grave e hipocalemia, antagonismo mineralocorticoide pode corrigir a tendência de perda de potássio.

A) Mais plausível entre as opções pela espironolactona; hidroclorotiazida pode agravar hipocalemia.

B) Associação de diuréticos perdedores de K tende a piorar a hipocalemia.

C) Hidroclorotiazida mantém risco de perda de potássio; glicerina não trata a síndrome.

D) Manitol e acetazolamida não constituem esquema anti-hipertensivo apropriado para o quadro.

> **Ressalva:** é necessário investigar hiperaldosteronismo primário e confirmar eletrólitos e bicarbonato; escolha não representa prescrição automática.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 39 | B

AINEs reduzem prostaglandinas renais vasodilatadoras, comprometendo a perfusão e a filtração em indivíduos suscetíveis.

A) Inibidores seletivos e não seletivos de COX podem causar lesão renal.

B) Correta: queda de PGE2/prostaciclina favorece vasoconstrição aferente e redução de TFG.

C) Deposição glomerular de metabólitos inativos não é o mecanismo típico.

D) É falsa porque A e C são falsas.

Referências relacionadas: [R01].

QUESTÃO 40 | B

Bloqueadores alfa-1 relaxam musculatura lisa prostática e do colo vesical; inibidores 5-alfa-redutase reduzem DHT.

A) 5-alfa-redutase converte testosterona em DHT; a alternativa inverte a enzima e afirma aumento de proliferação.

B) Correta: alívio do componente dinâmico da obstrução pela redução do tônus alfa-adrenérgico.

C) Alfa-bloqueadores podem causar hipotensão e alterações ejaculatórias; não são isentos desses efeitos.

D) É falsa porque A e C são incorretas.

Referências relacionadas: [R06].

Gabarito comentado - M1 - Reumatologia e demais áreas

Cada alternativa é examinada individualmente. As justificativas referem-se à redação efetivamente presente na prova.

QUESTÃO 01 | B

Reabilitação procura maximizar participação, autonomia e funcionalidade segundo os objetivos do paciente.

A) Errada: prevenção e redução de complicações também integram reabilitação.

B) Correta: o objetivo é a maior funcionalidade viável dentro do contexto individual.

C) Errada: dor crônica exige abordagem biopsicossocial e intervenções além de fisioterapia.

D) Errada: mobilização e reabilitação podem começar precocemente conforme estabilidade da fratura.

QUESTÃO 02 | B

Regra dos nove em adulto: membro superior inteiro equivale a 9%; metade da face anterior do tronco equivale a 9%.

A) 12% subestima a superfície descrita.

B) Correta: 9% de um membro superior mais 9% de metade do tronco anterior somam 18%.

C) 24% não corresponde às áreas informadas.

D) 28% excede a soma anatômica da regra dos nove.

Ressalva: área do braço refere-se ao membro superior quase inteiro e à metade do tronco anterior; expressão 'quase todo' torna 18% uma aproximação.

QUESTÃO 03 | A

Barlow avalia se quadril reduzido é luxável ao aduzir e aplicar pressão posterior; Ortolani reduz luxação.

A) Mais próxima: flexão e adução integram a manobra de Barlow, acrescida de pressão posterior.

B) Galeazzi pode ser normal em luxação bilateral simétrica.

C) Suspensório de Pavlik não é indicado indistintamente em quadris teratológicos rígidos.

D) Combinação complexa de osteotomias não é indicação universal em lactentes de 12 meses.

Ressalva: Barlow provoca/identifica instabilidade, não é o teste de redução da luxação já presente.

QUESTÃO 04 | A

Reflexo de Hoffmann sugere lesão de trato corticoespinal acima dos segmentos cervicais responsáveis pela mão.

A) Correta: lesão cervical C4-C5 pode produzir Hoffmann e sinais piramidais nos membros inferiores.

B) Lesão T8-T9 não costuma justificar Hoffmann positivo nas mãos.

C) Lesão T12-L1 pouparia reflexos de membro superior.

D) Lesão L4-L5 não explica sinais piramidais cervicais.

QUESTÃO 05 | C

Fratura de ambos os ossos do antebraço necessita imobilização que controle cotovelo e punho até fixação.

A) Imobilização inguino-podálica é de membro inferior.

B) Antebraquiopalmar não controla adequadamente a rotação do antebraço e cotovelo.

C) Correta: tala axilo-palmar longa oferece controle do cotovelo e punho.

D) Tóraco-braquial é imobilização para regiões proximais do membro superior.

QUESTÃO 06 | A

Paralisia obstétrica alta C5-C6, tipo Erb, causa assimetria de Moro e preservação relativamente maior da preensão.

A) Correta: reflexo de Moro assimétrico é achado clássico.

B) Ausência de preensão sugere lesão baixa C8-T1 ou extensa.

C) Mão em garra corresponde preferencialmente à paralisia obstétrica baixa.

D) Posição clássica é adução, rotação interna do ombro e pronação, não supinação.

QUESTÃO 07 | D

Dor, edema, deformidade, hematoma, crepitação e perda funcional sugerem fratura; sede e febre não são sinais específicos.

A) Inclui sinais válidos, mas omite edema/deformidade e hematoma.

B) Inclui sede e febre, inespecíficas de fratura.

C) Inclui sede e febre e omite dor.

D) Correta: I, II, III e IV são achados clínicos usuais.

QUESTÃO 08 | C

Fraturas expostas exigem antibiótico precoce, avaliação de cobertura e desbridamento cirúrgico conforme o caso.

A) Tamanho é elemento de Gustilo-Anderson, mas energia, contaminação, partes moles e vasculatura também importam.

B) Ferida de 4 cm em curral pode ter alta contaminação; tamanho sozinho não autoriza grau II.

C) Correta: infecção é complicação central e justifica limpeza e desbridamento apropriados.

D) Exposição prolongada não torna tratamento conservador preferível.

Ressalva: A é simplificação didática da classificação; C é a alternativa clinicamente mais segura.

QUESTÃO 09 | C

A 'hora de ouro' expressa a prioridade de atendimento ágil a trauma grave; infecções contribuem para mortalidade tardia.

A) Resposta e transporte oportunos influenciam prognóstico.

B) Após primeira semana predominam complicações tardias, não exclusivamente choque hemorrágico.

C) Correta no modelo clássico: infecções e disfunção orgânica contribuem para óbitos tardios.

D) Errada porque C é defensável.

Ressalva: a distribuição trimodal clássica de mortalidade é simplificada e não descreve todos os sistemas atuais.

QUESTÃO 10 | C

Expansão tecidual do couro cabeludo gera retalho local com cabelo, textura e cor semelhantes.

A) Exige colocação do expansor e sua retirada, não necessariamente menos anestesias.

B) Requer consultas e expansões seriadas, não menos acompanhamentos.

C) Correta: permite cobertura de alopecia com pele pilosa vizinha.

D) Expansão é processo lento de semanas ou meses.

QUESTÃO 11 | D

Padrões FAN devem ser correlacionados com alvo antigênico: membrana, homogêneo, centrômero, DFS70, grosso e fino.

A) Associa centrômero com anti-LEDGF, invertendo os padrões III e IV, entre outros erros.

B) Relaciona padrões homogêneo e centromérico a anticorpos incompatíveis.

C) Troca as correlações de padrão homogêneo/DFS70 e outros.

D) Correta na estrutura da questão: I-4, II-2, III-5, IV-1, V-6, VI-3.

Ressalva: um padrão de FAN não determina sozinho autoanticorpo nem diagnóstico; descrição de antígenos é resumida e antiga.

Referências relacionadas: [R02].

QUESTÃO 12 | A

Associação: anti-RNP/DMTC, anti-DNA/LES-nefrite, anti-histona/lúpus induzido, c-ANCA/GPA, anti-Ro/Sjögren.

A) Correta: sequência 3,4,1,2,5.

B) Distribuição não corresponde a nenhuma ordem clínica completa.

C) Confunde as associações de anti-histona e anti-Ro, entre outras.

D) Coloca anti-Ro na DMTC e anti-RNP em Sjögren, inadequadamente.

QUESTÃO 13 | A COM RESSALVA

Ferritina é útil para pesquisar deficiência de ferro, mas não se deve depender de sangue oculto para decidir investigação endoscópica.

A) Resposta tradicional pretendida: II e IV; a IV é atualmente inadequada se interpretada como triagem obrigatória ou suficiente.

B) Ferro sérico isolado discrimina mal ferropriva e inflamação; III não é boa diferenciação isolada.

C) Inclui III, que não separa adequadamente anemia ferropriva da megaloblástica sozinha.

D) Inclui I, falsa: ferro sérico oscila e sofre influência inflamatória.

Ressalva: tecnicamente a afirmativa II é a única claramente correta entre as quatro; não há alternativa contendo só II. Em homens e mulheres pós-menopausa com anemia ferropriva confirmada, investigar o TGI sem depender do teste de sangue oculto.

Referências relacionadas: [R13].

QUESTÃO 14 | A

O uso acidental e repetido de metotrexato pode causar toxicidade grave; exige suspensão e resgate com leucovorina.

A) Correta: suspender MTX, iniciar ácido folínico e monitorar sangue, rim, fígado e mucosas.

B) Ácido fólico rotineiro não substitui leucovorina no resgate de intoxicação estabelecida.

C) Vitamina E não é antídoto para metotrexato.

D) Manter o MTX perpetua a exposição tóxica.

Ressalva: intoxicação é urgência médica; a dose de resgate depende da gravidade e evolução.

Referências relacionadas: [R11].

QUESTÃO 15 | D

Em crise de gota com DRC significativa e angina instável, corticosteroide é frequentemente mais apropriado que AINE.

A) Quadro agudo de podagra recorrente não é típico de artrite reumatoide.

B) Alopurinol controla urato a longo prazo; não substitui anti-inflamatório na crise.

C) AINE pode agravar função renal e risco cardiovascular.

D) Correta: corticosteroide oral ou intra-articular é alternativa adequada quando AINE/colchicina são problemáticos.

Ressalva: colchicina em doses ajustadas pode ser opção em alguns pacientes; alopurinol pode ser iniciado durante crise com cobertura anti-inflamatória quando indicado.

Referências relacionadas: [R10].

QUESTÃO 16 | C COM RESSALVA

I é verdadeira; III é falsa; II e IV são formulações demasiado absolutas diante do tratamento individualizado atual.

A) I é verdadeira; II não obriga metotrexato para toda AR de baixa atividade, podendo-se preferir hidroxicloroquina.

B) Contém III, falsa: bloqueador TNF não é monoterapia inicial de escolha na AR de baixa atividade.

C) É a resposta convencional da prova se II for interpretada como opção aceitável e IV como possibilidade terapêutica.

D) Inclui III, falsa.

Ressalva: diretriz ACR 2021 prefere condicionalmente hidroxicloroquina em baixa atividade e após falha ao metotrexato considera também biológicos/JAK; portanto C não é regra universal.

Referências relacionadas: [R09].

QUESTÃO 17 | B COM RESSALVA

MTX é DMARD convencional, colestiramina acelera eliminação de leflunomida, ciclosporina inibe ativação de linfócitos T; JAK inibidores não são anticorpos.

A) Omitiria III, que pode ser considerada verdadeira quanto à supressão de linfócitos T, incluindo CD8.

B) Mais correta: I, II e III verdadeiras no sentido farmacológico amplo.

C) Inclui IV, falsa: tofacitinibe e baricitinibe são moléculas pequenas, não anticorpos monoclonais.

D) Inclui IV, falsa.

Ressalva: III é imprecisa se sugerir ação exclusiva em células CD8; ciclosporina atua na via calcineurina/NFAT de diversas células T.

Referências relacionadas: [R09].

QUESTÃO 18 | D

Para aliviar carga no joelho direito, bengala na mão esquerda avança junto com membro inferior direito.

A) Usar no lado doloroso reduz a vantagem biomecânica.

B) Se bengala à esquerda, deve acompanhar a perna direita, não esquerda.

C) Mão direita com perna direita não é padrão recomendado.

D) Correta: mão esquerda e perna contralateral direita avançam juntas.

QUESTÃO 19 | A

Delirium tem instalação aguda ou subaguda, flutuação, alteração de atenção e possível mudança de consciência.

A) Correta: CAM avalia começo agudo/flutuação, desatenção e outros componentes.

B) Delirium é comum em idosos hospitalizados, não raro por doenças crônicas.

C) Declínio insidioso e progressivo descreve melhor síndrome demencial.

D) Tratamento principal é identificar causas e medidas não farmacológicas; haloperidol IV não é obrigatório e tem riscos.

Referências relacionadas: [R11].

QUESTÃO 20 | B

Eritema sacral persistente com pele intacta, em ponto de pressão, sugere lesão por pressão estágio 1.

A) Dermatite por fralda é possível diferencial, mas a descrição focal sacral é típica de pressão.

B) Correta: eritema não branqueável sobre pele íntegra em proeminência óssea.

C) Candidíase costuma causar eritema em dobras com lesões satélites.

D) Alergia medicamentosa tipicamente não se restringe à área sacral.

Ressalva: confirmação exige examinar se o eritema é não branqueável e considerar lesões relacionadas à umidade.

QUESTÃO 21 | C

GDS de Yesavage reduz interferência de sintomas somáticos de doenças físicas frequentes na velhice.

A) Não é instrumento diagnóstico específico de depressão associada à demência grave.

B) Não distingue de forma definitiva depressão e luto normal ou prolongado.

C) Correta: versão tradicional foca sintomas afetivos/cognitivos, com pouca ou nenhuma ênfase em queixas somáticas.

D) Não é instrumento específico para avaliação de risco suicida.

Referências relacionadas: [R11].

QUESTÃO 22 | A

Associações comerciais não mudam o número de princípios ativos: são seis substâncias e amitriptilina é potencialmente inapropriada.

A) Correta: polifarmácia por pelo menos cinco fármacos distintos, com risco anticolinérgico de amitriptilina.

B) Nega ambas as condições apesar de seis princípios ativos e tricíclico.

C) Conta comprimidos em vez de fármacos e desconsidera combinações.

D) Incorreta ao considerar amitriptilina apropriada indiscriminadamente em idoso.

Referências relacionadas: [R11].

QUESTÃO 23 | B

A paciente possui múltiplas condições crônicas de diferentes sistemas, além de polineuropatia diabética.

A) Multimorbidade existe independentemente de doença índice.

B) Melhor opção: multimorbidade complexa, com complicação de diabetes.

C) Polineuropatia é complicação crônica, contrariando o enunciado.

D) Focar uma doença índice é menos representativo na abordagem geriátrica da multimorbidade.

Ressalva: definição operacional de 'multimorbidade complexa' depende do critério usado.

Referências relacionadas: [R11].

QUESTÃO 24 | C

Parkinsonismo de surgimento próximo às flutuações cognitivas e alucinações visuais vívidas favorece demência com corpos de Lewy.

A) Microangiopatia discreta não explicaria tão bem os sinais nucleares descritos.

B) Demência da doença de Parkinson exige demência após pelo menos um ano de Parkinson motor estabelecido.

C) Mais provável: demência com corpos de Lewy pelo conjunto de características clínicas.

D) Frontotemporal comportamental não costuma estrear com alucinações visuais e parkinsonismo dessa maneira.

Ressalva: o enunciado da questão 24 termina antes de apresentar todos os testes da AGA; classificação final depende de avaliação detalhada.

Referências relacionadas: [R12].

QUESTÃO 25 | SEM RESPOSTA SEGURA

A seção clínica do senhor JPC não apresenta os resultados prometidos de força, massa muscular e desempenho; não é possível graduar sarcopenia.

A) Não se pode excluir sarcopenia apenas por haver doença neurocognitiva.

B) Provável sarcopenia exigiria documentação de baixa força; ela não consta do caso disponibilizado.

C) Quedas não substituem confirmação de baixa massa muscular e força.

D) Gravidade depende de força, massa e desempenho anormais comprovados, não apresentados.

Ressalva: os valores de força/DXA anteriores pertencem à Sra. MASV, não ao Sr. JPC; não transferir dados entre pacientes.

Referências relacionadas: [R12].

QUESTÃO 26 | SEM RESPOSTA SEGURA

A escala clínica de fragilidade considera dependência basal e limitações funcionais; dados do JPC são insuficientes para discriminar 5 e 6 com segurança.

A) Não há sinais de terminalidade ou dependência extrema.

B) Fragilidade moderada exige dependência para atividades externas e manutenção doméstica, não detalhadas o bastante.

C) Fragilidade leve é plausível, mas não confirmável sem avaliar independência em AIVD.

D) Doença com quedas e déficits torna 'regular sem fragilidade' pouco provável, mas o escore não pode ser fechado.

Ressalva: falta a parte da AGA que o enunciado promete; evitar pontuação arbitrária.

Referências relacionadas: [R12].

QUESTÃO 27 | A

Com disfagia, perda ponderal e risco de quedas, reabilitação motora, avaliação da deglutição e suporte nutricional são prioridades.

A) Correta: fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição atendem os problemas mais urgentes descritos.

B) Massagem não substitui assistência fonoaudiológica na disfagia.

C) Não contempla diretamente fisioterapia e disfagia.

D) Não prioriza fonoaudiologia para possível aspiração nem suporte dietético.

QUESTÃO 28 | B

Em AR: nódulos de Heberden são da osteoartrite; poliartrite de pequenas juntas é típica; altas taxas de FR podem predizer pior prognóstico.

A) Considera primeira assertiva verdadeira e quarta falsa, ambas incorretas.

B) Correta: F, V, F, V.

C) Erra ao classificar como falso o valor prognóstico de FR em títulos elevados.

D) Erra sobre Heberden, poliartrite e condroprotetores.

Referências relacionadas: [R09].

QUESTÃO 29 | D

HLA-B27, uveíte anterior e dor lombar inflamatória são características da espondiloartrite axial.

A) Inclui II, que confunde osteófitos degenerativos com sindesmófitos inflamatórios.

B) Também inclui II e omite I.

C) Inclui II e omite a uveíte anterior.

D) Correta: I, III e IV verdadeiras.

Referências relacionadas: [R09].

QUESTÃO 30 | B

Gota manifesta-se classicamente por artrite de início abrupto, frequentemente monoarticular, muito dolorosa.

A) Altas doses de AAS tendem a ser uricosúricas; baixas doses podem elevar urato, portanto enunciado erra a dose.

B) Correta: ataque agudo com rubor, calor, edema e dor em horas.

C) Urato sérico durante crise pode estar normal; início de hipouricemiante depende de indicação, com profilaxia adequada.

D) Gota recorrente pode causar erosões, tofos e dano articular definitivo.

Referências relacionadas: [R10].

QUESTÃO 31 | B

Eritema malar, fotossensibilidade, úlceras orais e artrite são sugestivos de LES; consumo do complemento pode acompanhar atividade.

A) Leucocitose neutrofílica não é achado específico; leucopenia pode ocorrer no LES.

B) Correta: C3 e C4 reduzidos por consumo em LES ativo.

C) Anti-Scl-70 associa-se à esclerose sistêmica.

D) FR pode coexistir em LES, mas é inespecífico e menos representativo.

Referências relacionadas: [R02].

QUESTÃO 32 | C

Uso crônico de glicocorticoide eleva risco de perda óssea; medidas preventivas incluem avaliação de risco, cálcio e vitamina D.

A) Prednisona pode ser indicada em doença inflamatória intestinal, conforme gravidade.

B) Altas doses causam mais frequentemente hiperglicemia e hipertensão do que hipo/hipo.

C) Correta como parte da prevenção, mas muitos pacientes requerem também fármaco antiosteoporótico.

D) Prednisona, metilprednisolona e dexametasona diferem muito em potência e ação mineralocorticoide.

Referências relacionadas: [R14].

QUESTÃO 33 | A

Inibição de COX-1 reduz prostaglandinas gastroprotetoras, favorecendo gastropatia por AINE.

A) Correta: COX-1 participa da proteção da mucosa gástrica.

B) COX-2 tem papel inflamatório e sua inibição relativa não é a principal explicação clássica da lesão gástrica.

C) Fosfodiesterase não é alvo dos AINEs tradicionais.

D) Dihidroorotato desidrogenase é alvo de leflunomida, não da nimesulida.

QUESTÃO 34 | D

Dor difusa crônica, fadiga, sono/afeto alterados, ausência de sinovite e marcadores normais sugerem fibromialgia.

A) Prednisona não é tratamento de rotina de fibromialgia.

B) COX-2 seletivo não corrige mecanismos centrais da dor e não é estratégia principal.

C) Metotrexato é DMARD para doenças inflamatórias, não para fibromialgia.

D) Correta entre opções: pregabalina pode ajudar em dor e sono; exercícios e educação são fundamentais.

> **Ressalva:** tratamento individualizado e não farmacológico é a base; não se deve prescrever automaticamente pregabalina para todos.

Referências relacionadas: [R09].

QUESTÃO 35 | B

Glicocorticoides sistêmicos, heparina prolongada e alguns anticonvulsivantes podem contribuir para osteoporose.

A) Hidroclorotiazida costuma reduzir calciúria e não é causa típica de osteoporose.

B) Correta: deflazacorte, heparina e carbamazepina associam-se a risco ósseo.

C) É repetição da alternativa A e continua incorreta.

D) Carisoprodol aumenta risco de quedas, mas não é causa clássica de osteoporose medicamentosa.

Referências relacionadas: [R14].

QUESTÃO 36 | A

Osteoartrite envolve desequilíbrio entre síntese e degradação de matriz por condrócitos e mediadores catabólicos.

A) Correta: condrócitos produzem metaloproteinases e outras proteases catabólicas.

B) IGF-1 costuma favorecer matriz e sobrevivência dos condrócitos, não ser descrito primariamente como pró-protease.

C) Óxido nítrico em excesso favorece catabolismo e inibição de matriz, não anabolismo de proteoglicanos.

D) Menor ativador do plasminogênio e maior PAI-1 tendem a reduzir, não aumentar, plasmina.

QUESTÃO 37 | B

Sintomas de neuropatia mediana no túnel do carpo, Tinel positivo e atrofia tenar são favorecidos por diabetes e hipotireoidismo.

A) Trabalho manual pode contribuir, mas idade/profissão são menos explicativas que as doenças presentes.

B) Correta: diabetes e hipotireoidismo associam-se à síndrome do túnel do carpo.

C) Sexo feminino e trabalho repetitivo são riscos, porém menos específicos diante das comorbidades.

D) Menopausa pode contribuir, mas não explica tão bem a bilateralidade e os sinais dados.

Referências relacionadas: [R11].

QUESTÃO 38 | SEM RESPOSTA SEGURA

A alternativa A está cortada; múltiplos nódulos superficiais podem representar lipomas, mas não é possível afirmar o texto da opção perdida.

A) Nome truncado terminando em 'oma'; se fosse lipoma seria hipótese benigna plausível, mas não se pode reconstruir oficialmente.

B) Hemangioma é tumor vascular e exigiria achados de imagem específicos não descritos.

C) Rabdomiossarcoma embrionário é raro nessa faixa e apresentação.

D) Sarcoma pleomórfico alto grau requer suspeita por critérios de profundidade, crescimento e imagem, não comprovados.

E) Osteoma é tumor ósseo e não explica nódulos subcutâneos.

Ressalva: não atribuir 'A' sem ler o nome da alternativa.

QUESTÃO 39 | D

Sarcomas de partes moles costumam metastatizar por via hematogênica e tumores retroperitoneais são descobertos tardiamente.

A) Linfonodos não são a principal via metastática da maioria dos sarcomas.

B) RM define extensão, não costuma determinar sozinha histologia tumoral.

C) Sarcomas de partes moles são mais frequentes em adultos e idosos que em crianças.

D) Correta: localização retroperitoneal associa-se a dificuldade de ressecção e pior prognóstico.

QUESTÃO 40 | B

Lesão de partes moles maior que 5 cm, profunda ou em crescimento requer investigação em centro especializado e possível biópsia planejada.

A) Dor e crescimento rápido são sinais de alerta, mas rubor pode ter diversas causas e não é indicação isolada padronizada.

B) Correta: tamanho maior que 5 cm e progressão aumentam suspeita de malignidade.

C) Trauma e história familiar isolados não definem indicação formal de biópsia.

D) Proximidade de grande articulação isoladamente não indica biópsia.

Ressalva: alguns tumores menores de 5 cm também exigem investigação se houver sinais suspeitos.

QUESTÃO 41 | A

Radiografia simples é método de projeção, com radiação ionizante, usualmente obtida em ao menos duas incidências.

A) Correta como EXCETO: radiografia não é técnica verdadeiramente multiplanar como TC ou RM.

B) Utiliza radiação ionizante, portanto afirmação correta sobre radiografia.

C) Ao menos duas incidências ortogonais são recomendadas em muitas avaliações musculoesqueléticas.

D) É amplamente acessível e custo relativamente baixo.

QUESTÃO 42 | D

Radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância integram o núcleo do arsenal de imagem musculoesquelética.

A) Bursografia não é método rotineiro de primeira linha.

B) Discografia não compõe exames mais usados genericamente.

C) Mielografia é recurso específico e não um dos quatro métodos usuais atuais.

D) Correta: radiografia, US, TC e RM.

QUESTÃO 43 | A

Pinçamento focal, esclerose subcondral, osteófitos e cistos são clássicos de osteoartrite.

A) Correta: padrão radiográfico degenerativo de osteoartrite.

B) Artrite psoriásica tem erosões e proliferação óssea característica, não esse conjunto clássico.

C) Artrite reumatoide costuma gerar osteopenia periarticular e erosões marginais.

D) Gota pode apresentar erosões 'em saca-bocado' e relativa preservação do espaço inicial.

Referências bibliográficas

Fontes consultáveis utilizadas na verificação dos conceitos clínicos e diretrizes. A seleção não significa endosso de formulações inadequadas nas questões originais.

[R01] KDIGO, 2024. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD.
https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/kdigo-2024-ckd-guideline/

[R02] KDIGO, 2024. Guideline for the Management of Lupus Nephritis.
https://kdigo.org/guidelines/lupus%20nephritis/

[R03] KDIGO. Clinical Practice Guidelines on Glomerular Diseases.
https://kdigo.org/guidelines/gd/

[R04] American Urological Association, 2025. Microhematuria: AUA/SUFU Guideline.
https://www.auanet.org/documents/Guidelines/PDF/2025%20Guidelines/MH%20Unabridged%2002.2025FINAL3-1.pdf

[R05] EAU, 2026. Guidelines on Prostate Cancer - Treatment.
https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/chapter/treatment

[R06] EAU, 2026. Management of Non-neurogenic Male LUTS - Disease Management.
https://uroweb.org/guidelines/management-of-non-neurogenic-male-luts/chapter/disease-management

[R07] EAU, 2026. Urethral Strictures - Disease Management in Males.
https://uroweb.org/guidelines/urethral-strictures/chapter/disease-management-in-males

[R08] EAU, 2026. Guidelines on Urolithiasis.
https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/chapter/guidelines

[R09] Fraenkel et al., 2021. ACR Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273041/

[R10] FitzGerald et al., 2020. ACR Guideline for the Management of Gout.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10563586/

[R11] AGS, 2023. Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medications.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12478568/

[R12] Cruz-Jentoft et al., 2019. EWGSOP2: Sarcopenia, revised European consensus.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6322506/

[R13] AGA, 2020. Gastrointestinal Evaluation of Iron Deficiency Anemia.
https://gastro.org/clinical-guidance/gastrointestinal-evaluation-of-iron-deficiency-anemia/

[R14] Humphrey et al., 2023. ACR Guideline for Glucocorticoid-Induced Osteoporosis.
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.25240

Nota metodológica: a identificação de respostas tecnicamente inadequadas levou em conta a distinção entre o gabarito historicamente pretendido e a recomendação atual. O texto fonte não contém imagens incorporadas às páginas, conforme inspeção estrutural do PDF.